

**ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՈԽԼ I-Ի
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ**

Փաստաթղթի տարբերակ՝

1.3

Կարգավիճակ՝

ստորագրման համար

Պատվիրատու՝

Կատարող՝

Պայմանագրի ամսաթիվ՝

«__» _____ 20__ թ.

Փուլ I-ի մեկնարկի ամսաթիվ՝

«__» _____ 20__ թ.

Փաստաթուղթը սահմանում է Փուլ I-ի ամբողջական գործառնության ծավալը, բացառությունները, ընդունման պայմանները և կողմերի պարտականությունները:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. Փաստաթղթի նպատակը և իրավական նշանակությունը
2. Հիմնական տերմիններ
3. Փուլ I-ի նպատակները
4. Փուլերի ընդհանուր սահմանը
5. Փուլ I-ի գործառնության ծավալը
6. Փուլ I-ի հաշվետվությունների փակ գրանցամատյանը
7. Ձևանմուշներ, տեղեկատուներ և սկզբնական տվյալներ
8. API, արտաքին ինտեգրումներ և էլեկտրոնային հաստատում
9. Տվյալների սեփականություն և սկզբնական կոդ
10. Ծարտարապետական և ոչ գործառնության պահանջներ
11. Տեղակայում, միջավայրեր և տեխնիկական սպասարկում
12. Մատակարարվող արդյունքները
13. Իրականացման ժամկետ և արտադրական փորձնական շահագործում
14. Փորձարկում և ընդունում
15. Կողմերի պարտականությունները
16. Փուլ I-ում ուղղակիորեն չներառված ծավալը
17. Հետագա փուլերի ինդիկատիվ ուղղությունները
18. Առանձնահատուկ կարևոր սահմաններ՝ ստորագրելուց առաջ պարտադիր ընթերցման համար
19. Մինչև ստորագրումը պարտադիր լրացվող պայմաններ
20. Փաստաթղթի ամբողջականություն և փոփոխություններ
21. Կողմերի հաստատումը

1. Փաստաթղթի նպատակը և իրավական նշանակությունը

1.1. Սույն տեխնիկական առաջադրանքը (այսուհետ՝ **SU**) սահմանում է Միասնական բժշկական տեղեկատվական համակարգի (այսուհետ՝ **Համակարգ** կամ **HIS**) Փուլ I-ի մշակման, մատակարարման, փորձնական շահագործման և ընդունման ամբողջական գործառնության ծավալը:

1.2. Սույն SU-ն Պայմանագրի անբաժանելի մասն է: Փուլ I-ի ֆիքսված ծավալը որոշվում է բացառապես սույն SU-ում ուղղակիորեն ներառված պահանջներով: Սույն SU-ում չներառված գործառնությամբ, ինտեգրումը, հաշվետվություններ, ձևանմուշներ, ծառայություններ կամ ենթակառուցվածքային պարտավորություններ Փուլ I-ի մաս չի համարվում:

1.3. Կողմերի միջև նախկինում փոխանակված հայեցակարգերը, հարցաթերթերը, նախնական տեխնիկական պահանջները, ներկայացումները, նամակագրություններ և բանավոր քննարկումները կարող են օգտագործվել որպես բացատրական նյութ, սակայն Փուլ I-ի ծավալի վերաբերյալ հակասության դեպքում գերակայում են՝

1. Պայմանագիրը,
2. սույն ստորագրված SU-ն,
3. Պայմանագրի ստորագրված փոփոխությունները և փոփոխության հայտերը:

1.4. Նախնական փաստաթղթում հետագա մոդուլների համար նշված P1, «առաջին փուլում», «առնվազն», «օրինակ» կամ համանման բաց ձևակերպումները չեն ընդլայնում սույն SU-ի Փուլ I-ի փակ ծավալը: «Առնվազն» բառը սույն SU-ում նշանակում է միայն տվյալ կետում ուղղակիորեն թվարկված տեղեկատվական արդյունքների ամբողջություն և չի ստեղծում չսահմանափակված լրացուցիչ մշակման պարտավորություն:

1.5. Համակարգի՝ հետագա ընդլայնման կամ ինտեգրման համար տեխնիկապես պատրաստ լինելը չի նշանակում, որ համապատասխան հետագա մոդուլը կամ ինտեգրումն իրականացվում է Փուլ I-ում:

1.6. Փուլ II-ը, Փուլ III-ը և այլ հետագա աշխատանքները սույն SU-ում ներկայացվում են միայն Փուլ I-ի սահմանները հստակեցնելու նպատակով: Դրանց վերջնական կազմը, ժամկետը և արժեքը համաձայնեցվում են առանձին և ներառված չեն Փուլ I-ի ներկայիս արժեքում:

2. Հիմնական տերմիններ

Տերմին	Սահմանում
Փուլ I	Սույն SU-ում ուղղակիորեն ներառված ծրագրային գործառնությունների և մատակարարվող արդյունքների փակ ամբողջություն:
Հետագա փուլեր	Փուլ I-ից դուրս գտնվող աշխատանքներ, որոնք կարող են իրականացվել առանձին պայմանագրով կամ փոփոխության հայտով:
Ծրագրային թերություն	Համակարգի հաստատված վարքագծի անհամապատասխանություններ սույն SU-ի ուղղակի պահանջին:

Տերմին	Սահմանում
Փոփոխության հայտ	Նոր գործառույթ, նոր հաշվետվություն, նոր դեր, նոր ինտեգրում, աշխատանքի ընթացքի փոփոխություն կամ հաստատված պահանջի ընդլայնում:
Կրիտիկական/արգելափակող թերություն	Ծրագրային թերություն, Տեխնիկական առաջադրանքով ուղղակիորեն նախատեսված էական կամ հիմնական գործառույթի ամբողջական բացակայություն կամ այնպիսի անաշխատունակություն, որի հետևանքով անհնար է կամ էականորեն արգելափակվում է Համակարգի հիմնական աշխատանքային գործընթացներից որևէ մեկի իրականացումը: Կրիտիկական/արգելափակող թերություն է համարվում նաև այն դեպքը, երբ անհնար է մուտք գործել Համակարգ, գրանցել պացիենտ, պահպանել հիմնական բժշկական գրառում, իրականացնել առանցքային ֆինանսական գործողություն, կամ առաջանում է տվյալների կորուստ, վնասում, չարտոնված հասանելիություն կամ արտահոսք, պացիենտի անվտանգության համար էական վտանգ կամ էականորեն սխալ բժշկական կամ ֆինանսական արդյունք: Առանձին ոչ կրիտիկական սխալը, մասնակի թերությունը, տեսողական կամ տեխնիկական ոչ էական անհամապատասխանությունը, ինչպես նաև այն թերությունը, որը չի արգելափակում համապատասխան հիմնական աշխատանքային գործընթացը և ունի կիրառելի ժամանակավոր շրջանցման եղանակ, ինքնին կրիտիկական/արգելափակող թերություն չի համարվում: Ժամանակավոր շրջանցման եղանակի առկայությունը թերությունը չի դարձնում ոչ կրիտիկական, եթե այն ստեղծում է պացիենտի անվտանգության, տվյալների ամբողջականության կամ գաղտնիության էական վտանգ կամ հանգեցնում է էականորեն սխալ բժշկական կամ ֆինանսական արդյունքի:
Փորձնական թողարկում	Իրական արտադրական միջավայրում օգտագործման համար փոխանցվող տարբերակ, որով սկսվում է Պատվիրատուի արտադրական փորձնական շահագործումը:
Վերջնական ընդունում	Փուլ I-ի համապատասխանության հաստատում և վերջնական ընդունման ակտի ստորագրում:
Ներքին էլեկտրոնային հաստատում	Համակարգի ներսում կատարվող հաստատում՝ օգտատիրոջ, դերի, ամսաթվի, ժամի, փաստաթղթի տարբերակի և Audit Trail-ի պահպանմամբ:

Տերմին	Սահմանում
Արտաքին ինտեգրում	HIS-ի և երրորդ կողմի համակարգի, սարքավորման, պետական հարթակի կամ ծառայության ավտոմատ տվյալափոխանակություն:
Սկզբնական տեղեկատվություն	Գործարկման համար անհրաժեշտ՝ Պատվիրատուի կողմից պատրաստված և հաստատված կառուցվածքային տվյալներ:

3. Փուլ I-ի նպատակները

Փուլ I-ի նպատակներն են՝

- ստեղծել պացիենտի միասնական էլեկտրոնային քարտ և դեպքերի շարունակական պատմություն,
- թվայնացնել հիմնական ամբուլատոր և ստացիոնար աշխատանքային գործընթացները,
- ապահովել ախտորոշիչ ու բուժական պատվերների և արդյունքների բազային էլեկտրոնային շրջանառությունը,
- ապահովել վճարումների, հաշիվների և գանձապահական գործողությունների բազային հաշվառում,
- ղեկավարությանը տրամադրել առօրյա գործառնական ցուցանիշներ և սահմանված հաշվետվություններ,
- ապահովել դերային հասանելիություն, ներքին հաստատում և գործողությունների հետադծելիություն,
- ձևավորել հետագա մոդուլների և ինտեգրումների համար ընդլայնելի ճարտարապետական հիմք:

4. Փուլերի ընդհանուր սահմանը

Շրջանակ	Կարգավիճակ	Իրավական հետևանք
Սույն ՏԱ-ի բաժին 5-ում թվարկված յոթ հիմնական մոդուլները և բաժիններ 6-15-ի ուղղակի արդյունքները	Ներառված են Փուլ I-ում	Ընդգրկված են Փուլ I-ի ընդունման ծավալում:
Բաժին 16-ում թվարկված բացառությունները	Ներառված չեն Փուլ I-ում	Կարող են իրականացվել միայն առանձին համաձայնությամբ:
Բաժին 17-ի հետագա ուղղությունները	Ապագա հնարավոր ծավալ	Փուլ II/III-ի բաշխումը, ժամկետը և արժեքը պարտադիր չեն սույն ՏԱ-ով:

5. Փուլ I-ի գործառնության ծավալը

5.1. Պացիենտների գրանցում, նույնականացում և այցերի կազմակերպում

ID	Պարտադիր գործառնություն
REG-01	Պացիենտի նոր միասնական քարտի ստեղծում՝ անձնական, նույնականացման և կապի տվյալներով, կապի/վստահված անձի տվյալներով և քարտի եզակի համարով:
REG-02	Պացիենտի որոնում ըստ անվան, ազգանվան, ծննդյան ամսաթվի, հեռախոսի, քարտի համարի և նշված չափանիշների համակցության:
REG-03	Հավանական կրկնօրինակների հայտնաբերում և զգուշացում, ինչպես նաև լիազորված օգտատիրոջ կողմից կրկնօրինակ քարտերի վերահսկվող միավորում՝ պատմության պահպանմամբ:
REG-04	Բժիշկների աշխատանքային ժամանակացույցերի բազային վարում:
REG-05	Առաջին, կրկնակի և հերթական այցերի գրանցում, ազատ ժամանակի ընտրություն, այցի տեղափոխում և չեղարկում:
REG-06	Բժշկի ընթացիկ հերթի դիտում և կարգավիճակների թարմացում:
REG-07	Պացիենտի ամբուլատոր ու ստացիոնար դեպքերի, հետազոտությունների, նշանակումների, եզրակացությունների և վճարումների միասնական պատմության դիտում՝ ըստ իրավասության:
REG-08	Ներքին և արտաքին ուղեգրումների գրանցում և կապ համապատասխան այցի/դեպքի հետ:
REG-09	Գրանցման գործընթացից բխող համաձայնեցված տեղեկանքների ու ձևերի դիտում, PDF/տպագրում՝ Պատվիրատուի տրամադրած և հաստատած բովանդակության հիման վրա:

Սահմանափակումներ. Փուլ I-ը չի ներառում առցանց ինքնագրանցում, պացիենտի պորտալ, բջջային հավելված, ինքնասպասարկման տերմինալ, արտաքին SMS/e-mail հիշեցումներ կամ ապարատային հերթի համակարգի ինտեգրում: Շտապ օգնության դեպքում կիրառվում են նույն գրանցման և հոսպիտալացման բազային գործընթացները. առանձին տրիաժի/ED մոդուլ չի ստեղծվում:

5.2. Ամբուլատոր էլեկտրոնային բժշկական քարտ

ID	Պարտադիր գործառնություն
AMB-01	Նախապես գրանցված կամ չգրանցված ամբուլատոր այցի բացում՝ այցի տեսակով, պատասխանատու բժշկով, ստորաբաժանմամբ և ֆինանսական կարգավիճակով:
AMB-02	Բուժքրոջ նախնական գնահատման բազային գրանցում և բժշկին հասանելի դարձնելը:
AMB-03	Նախորդ բժշկական պատմության և համապատասխան փաստաթղթերի դիտում:
AMB-04	Գանգատների, հիվանդության և կյանքի անամնեզի, օբյեկտիվ ու մասնագիտացված զննման տվյալների գրանցում:

ID	Պարտադիր գործառույթ
AMB-05	Նախնական, հիմնական, ուղեկցող, տարբերակիչ և վերջնական ախտորոշումների գրանցում՝ կիրառվող ICD դասակարգիչով:
AMB-06	Լաբորատոր, ճառագայթային, ֆունկցիոնալ և էնդոսկոպիկ հետազոտությունների էլեկտրոնային պատվերների ստեղծում:
AMB-07	Մեկ այլ մասնագետի ներքին խորհրդատվության պատվեր և խորհրդատուի եզրակացության գրանցում:
AMB-08	Դեղորայքային նշանակումների գրանցում՝ անվանում, դեղաձև, դեղաչափ, ընդունման ուղի, հաճախականություն, տևողություն, ցուցումներ, ամսաթվեր և նշանակող բժիշկ:
AMB-09	Ոչ դեղորայքային բուժման, վերականգնման, սննդակարգի, միջամտությունների, ներարկումների և ինֆուզիաների նշանակումների գրանցում:
AMB-10	Այցի եզրակացության, խորհրդատվությունների և հետագա հանձնարարականների կազմում:
AMB-11	Տեղեկանքի, ուղեգրի, բուժման/հետազոտության պլանի և բժշկական քաղվածքի էլեկտրոնային ձևավորում, PDF և տպագրում:
AMB-12	Կրկնակի այցի և պարբերական հսկողության կապում նախորդ դեպքի հետ:
AMB-13	Բժշկական գրառման սևագիր, շարունակման, դիտման, ներքին հաստատման, վերահսկվող ուղղման և փակման կարգավիճակներ:
AMB-14	Հաստատված փաստաթղթի հայերեն էլեկտրոնային և տպագրելի տարբերակ՝ բժշկի նույնականացման տվյալներով:

Սահմանափակումներ. Ձայնից տեքստ փոխակերպումը, AI ամփոփումը, ամբողջական կլինիկական որոշումների աջակցման համակարգը, դեղերի փոխազդեցությունների և կրկնակի նշանակումների ավտոմատ բազան, պացիենտի հարցաթերթիկները, հեռաբժշկությունը և այլ կլինիկաներից ավտոմատ ներմուծումը Փուլ I-ում ներառված չեն: Պարտադիր դաշտերի լրացվածությունը վերահսկվում է տվյալ ձևի կարգավորումներով, իսկ բժշկական որոշման համար պատասխանատու է բուժաշխատողը:

5.3. Ստացիոնար էլեկտրոնային բժշկական քարտ

ID	Պարտադիր գործառույթ
INP-01	Հոսպիտալացման նոր դեպքի ստեղծում՝ տեսակ, հիմք, ուղեգրող կողմ, ընդունող բժիշկ, ստորաբաժանում և վճարման կարգավիճակ:
INP-02	Պլանային, շտապ/անհետաձգելի, տեղափոխմամբ և կրկնակի հոսպիտալացման տեսակների աջակցում:
INP-03	Ընդունման բժշկական գրառում՝ անամնեզ, վիճակ, ախտորոշումներ, ռիսկեր և բուժման նախնական պլան:

ID	Պարտադիր գործառույթ
INP-04	Ստորաբաժանումների, հիվանդասենյակների և մահճակալների ցանկ, ազատ/զբաղված կարգավիճակ, մահճակալի նշանակում և փոփոխում, տեղափոխում ու զբաղվածության ժամանակի պահպանում:
INP-05	Հետազոտության և բուժման պլան՝ ներառյալ նշանակված միջամտությունները, հսկողությունը և կանխարգելիչ գործողությունները:
INP-06	Ամենօրյա բժշկական գրառումներ, դինամիկայի և որոշումների պահպանում:
INP-07	Հերթապահ բժշկի գրառում, վատթարացման/շտապ գործողությունների, շրջայցի և կոնսիլիումի փաստաթղթավորում:
INP-08	Հերթափոխի հանձնում, կենսական ցուցանիշների գրանցում, նշանակված/կատարված գործողություններ, հիմնական խնամք, սննդակարգ և շարժողական ռեժիմ, հեղուկների հաշվեկշիռ, ընկնելու և պառկելախոցի ռիսկերի գրանցում:
INP-09	Դեղերի, ներարկումների և ինֆուզիաների նշանակման, կատարման կամ չկատարման գրանցում՝ պատճառի պահպանմամբ:
INP-10	Ստացիոնար հետազոտությունների և մասնագիտական խորհրդատվությունների պատվերներ ու արդյունքների կապում դեպքի հետ:
INP-11	Արդեն կատարված վիրահատության/միջամտության փաստաթղթավորում՝ անվանում, ցուցում, ամսաթիվ/ժամ, թիվ, անզգայացման տեսակ, համառոտ նկարագրություն, արդյունք, բարդություններ, հետվիրահատական ցուցումներ և կցորդներ:
INP-12	Ներհիվանդանոցային տեղափոխումների պատմություն:
INP-13	Դուրսգրման էպիկրիզ, դեպքի ավարտի տեսակի գրանցում և ստացիոնար դեպքի փակում:

Սահմանափակումներ. Փուլ I-ը չի ներառում վիրահատարանների օրացույցի, սրահների, սարքավորումների և թիմերի ռեսուրսային պլանավորման ամբողջական մոդուլ: ICU-ում կիրառվում է սույն բաժնի ստանդարտ ստացիոնար և բազային բուժքույրական գործընթացը՝ առանց սարքերից ավտոմատ տվյալների ներմուծման, օդափոխության թվային ամբողջական կառավարման, ինֆուզիոն պոմպերի ինտեգրման կամ առանձին չթվարկված ICU աշխատանքային հոսքերի:

5.4. Ախտորոշիչ և բուժական պատվերներ ու արդյունքներ

ID	Պարտադիր գործառույթ
DIA-01	Ծառայությունների միասնական կատալոգ, էլեկտրոնային պատվեր, հրատապության աստիճան, պացիենտի/դեպքի հետ կապ և պատվերի կարգավիճակներ:
DIA-02	Ծառայության համար ամսաթվի, ժամի և կիրառելի ռեսուրսի բազային նշանակում:
DIA-03	Պատվերի ստեղծման, ընդունման, կատարման, չկատարման, չեղարկման և արդյունքի պատրաստման կարգավիճակների պատմություն:

ID	Պարտադիր գործառնություն
LAB-01	Լաբորատոր պատվեր, նմուշի տեսակ, նմուշառում, լաբորատորիայում ստացում կամ պատճառաբանված մերժում:
LAB-02	Թվային, տեքստային և դրական/բացասական արդյունքի ձեռքով մուտքագրում՝ չափման միավորով, հղումային միջակայքով և մեկնաբանությամբ:
LAB-03	Արդյունքի սևագիր, տեխնիկական ստուգում, մասնագիտական հաստատում և հաստատված արդյունքի վերահսկվող ուղղում:
LAB-04	Կրիտիկական արդյունքի նշում և պատասխանատու բժշկին տեղեկացնելու փաստի գրանցում:
RAD-01	Ճառագայթային հետազոտության պատվեր, հերթագրում, կատարման փաստ, նկարագրություն, եզրակացություն, հեղինակ, սևագիր և հաստատում:
RAD-02	PDF փաստաթղթի կամ ընդունելի բժշկական պատկերի ձեռքով կցում:
RAD-03	Ռենտգենի, ուլտրաձայնային հետազոտության, համակարգչային տոմոգրաֆիայի, մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիայի և դենսիտոմետրիայի ձեռքով աշխատանքային հոսք՝ ըստ կլինիկայում կիրառելի ծառայությունների:
FDI-01	Ֆունկցիոնալ ախտորոշման պատվեր, կարգավիճակ, արձանագրություն, եզրակացություն և հաստատում՝ ԷՍԳ, ԷԷԳ, ԷՆՄԳ, սպիրոմետրիա և կատալոգում ներառված այլ ծառայություններ:
END-01	Էնդոսկոպիկ ծառայության պատվեր, հերթագրում, արձանագրություն, նկարագրություն, եզրակացություն, բարդություններ և կցորդներ:
TRT-01	Բուժական/ինտերվենցիոն ծառայության պատվեր, կատարման փաստ, կատարող, արդյունք, բարդություններ և օգտագործված դեղերի/նյութերի առնվազն տեքստային գրանցում:
DIA-04	Արդյունքների որոնում, դիտում, դեպքի և պացիենտի քարտի հետ կապ, ներքին հաստատում և վերահսկվող ուղղում:

Ինտեգրացիոն սահման. Լաբորատոր սարքերից արդյունքների ավտոմատ ներմուծումը, լիարժեք LIS-ը, շտրիխկոդային ամբողջական նմուշային հոսքը, լաբորատոր որակի վերահսկման մոդուլը, PACS/RIS/DICOM-ը, ռենտգեն/ԿՏ/ՄՌՏ/ՈւՁՀ և այլ բժշկական սարքավորումների ինտեգրումները Փուլ I-ում ներառված չեն: Փուլ I-ում նշված ծառայությունները գործում են ձեռքով տվյալների մուտքագրմամբ, եզրակացության կազմմամբ և ֆայլերի կցմամբ:

5.5. Վճարումներ, գանձապահ և բազային ֆինանսական հաշվառում

ID	Պարտադիր գործառնություն
FIN-01	Ծառայությունների գնացուցակ՝ ներքին կող, կատեգորիա, կատարող ստորաբաժանում, հիմնական գին, գործողության սկիզբ, ակտիվ/ոչ ակտիվ կարգավիճակ, վճարողից/պայմանագրից կախված գներ և գների տարբերակների պատմություն:
FIN-02	Պացիենտի հաշվի ձևավորում այցի, ծառայության, հետազոտության, միջամտության, հոսպիտալացման կամ ծառայությունների փաթեթի հիման վրա:

ID	Պարտադիր գործառնություն
FIN-03	Հաշվում պացիենտի, դեպքի, ծառայությունների, գների, զեղչերի, վճարողների, վճարված գումարի, մնացորդի և ընդհանուր արժեքի պահպանում, նույն ծառայության պատահական կրկնակի հաշվարկի կանխարգելում:
FIN-04	Կանխիկ, բանկային քարտով, բանկային փոխանցմամբ, կանխավճարով, մասնակի, պայմանագրային և ապահովագրական վճարման ձեռքով գրանցում՝ գումար, AMD արժույթ, եղանակ, ամսաթիվ/ժամ, գանձապահ, հաշիվ և արտաքին գործարքի/փաստաթղթի համար:
FIN-05	Կանխավճարի ընդունում, պացիենտի հետ կապում, մի քանի ծառայությունների համար օգտագործում, մնացորդ և օգտագործման պատմություն:
FIN-06	Մասնակի վճարում և չվճարված մնացորդի հաշվարկ:
FIN-07	Տոկոսային կամ ֆիքսված զեղչ՝ տեսակ, պատճառ, լիազորված աշխատակից և ըստ դերի առավելագույն թույլատրելի չափ:
FIN-08	Լրիվ կամ մասնակի վերադարձ՝ պատճառ, սկզբնական վճարում/ծառայություն, հաստատող աշխատակից, ամսաթիվ/ժամ և առանձին հակադարձ գործարք՝ առանց սկզբնական վճարման ջնջման:
FIN-09	Չվճարված և մասնակի վճարված հաշիվներ, պացիենտի ու կազմակերպության պարտք, ժամկետ, կարգավիճակ և մարումը սկզբնական հաշվի հետ կապելու հնարավորություն:
FIN-10	Վճարողներ՝ պացիենտ, այլ ֆիզիկական անձ, ապահովագրող, գործատու, պայմանագրային կազմակերպություն, պետական/նպատակային ծրագիր և մեկ դեպքի գումարի բաժանում մի քանի վճարողի միջև:
FIN-11	Գանձապահական հերթափոխի բացում, կիրառելի սկզբնական մնացորդ, գործարքների ընթացիկ ամփոփում, փակում և վերջնական հերթափոխային հաշվետվություն:
FIN-12	Ներքին ֆինանսական փաստաթղթեր՝ պացիենտի հաշիվ, վճարման հաստատում, կանխավճարի փաստաթուղթ, վերադարձի փաստաթուղթ, պարտքի տեղեկանք և գանձապահական հերթափոխի հաշվետվություն:
FIN-13	Ամբուլատոր և ստացիոնար ֆինանսական դեպքեր, ընթացիկ ու վերջնական հաշիվ, ծառայության բժշկական և վճարային կարգավիճակների տարանջատում:
FIN-14	Վճարումների, հասույթի, վերադարձների, զեղչերի և պարտքերի արտահանում Excel կամ մեկ այլ համաձայնեցված կառուցվածքային ֆայլով:
FIN-15	Ֆինանսական գործողությունների դերային սահմանափակում և ամբողջական Audit Trail:

Ֆինանսական սահման. Քարտով կամ փոխանցմամբ վճարումը HIS-ում ձեռքով գրանցվում է արտաքին բանկային/POS համակարգում գործարքի կատարումից հետո: POS/acquiring, առցանց վճարում, հարկային/ֆիսկալ համակարգի ավտոմատ ինտեգրում և հաշվապահական ծրագրի ավտոմատ կապակցիչ ներառված չեն: HIS-ը ստեղծում է ներքին ֆինանսական փաստաթղթեր և համաձայնեցված կառուցվածքային արտահանման ֆայլ: Կիրառվող արտաքին ֆիսկալ լուծման իրավաչափության համար պատասխանատու է Պատվիրատուն:

Պայմանագրային և ապահովագրական սահման. Փուլ I-ում կազմակերպությունը կամ ապահովագրողը ձեռքով ընտրվում է որպես վճարող, և գրանցվում են գինը, ֆինանսական

բաժնեմասը, սպասվող գումարը, վճարային կարգավիճակը և պարտքը: Պայմանագրերի ամբողջական գրանցամատյանը, գործողության ժամկետները, սահմանաչափերը, ծառայությունների նախնական համաձայնեցումը, ապահովագրական պոլիսը, eligibility/coverage ստուգումը, pre-authorization-ը, claims գործընթացը և արտաքին տվյալափոխանակությունը ներառված չեն:

5.6. Ղեկավարական հաշվետվություններ և գործառնական վերահսկողություն

ID	Պարտադիր գործառնություն
REP-01	Գլխավոր գործառնական վահանակ՝ ընթացիկ ամբուլատոր, ստացիոնար, ախտորոշիչ և ֆինանսական ցուցանիշներով:
REP-02	Ամբուլատոր գործունեության ընթացիկ վերահսկում՝ նշանակված, կատարված և չկայացած այցեր, սպասող պացիենտներ և բժիշկների ծանրաբեռնվածություն:
REP-03	Ստացիոնար գործունեության և մահճակալային ֆոնդի ընթացիկ վերահսկում՝ հոսպիտալացումներ, դուրսգրումներ, տեղափոխումներ, ազատ/զբաղված մահճակալներ և ստորաբաժանումների ծանրաբեռնվածություն:
REP-04	Ախտորոշիչ պատվերների ու ծառայությունների ընթացիկ վերահսկում՝ նշանակված, կատարված, չկատարված և հաստատման սպասող արդյունքներ:
REP-05	Օրվա բազային ֆինանսական ամփոփում՝ հասույթ, կանխիկ/անկանխիկ վճարումներ, չվճարված ծառայություններ, վերադարձներ և զեղչեր:
REP-06	Ներկառուցված ցանկի սահմաններում կարգավորվող գործառնական ծանուցումների ցուցադրում՝ չհաստատված արդյունքներ, երկար չավարտված բժշկական գրառումներ, ծանրաբեռնված ստորաբաժանումներ, չփակված ստացիոնար դեպքեր, չփակված գանձապահական հերթափոխեր, կրիտիկական լաբորատոր արդյունքներ և համակարգային ծանուցումներ:
REP-07	Բաժին 6-ում սահմանված փակ հաշվետվական արդյունքների դիտում, զտում, PDF/Excel արտահանում և տպագրում՝ ըստ օգտատիրոջ իրավասության:

Սահմանափակումներ. Փուլ I-ը չի ներառում ընդհանուր նշանակության հաշվետվությունների կոնստրուկտոր, ամբողջական BI, ռազմավարական վերլուծություն, կանխատեսումներ, շահութաբերության խորքային հաշվարկ, որակի ընդլայնված KPI-ներ կամ յուրաքանչյուր օգտատիրոջ անհատական վահանակի կոնստրուկտոր:

5.7. Օգտատերեր, դերեր, իրավունքներ և համակարգային կառավարում

ID	Պարտադիր գործառնություն
ADM-01	Յուրաքանչյուր աշխատակցի եզակի հաշիվ, հաշվի ակտիվացում, արգելափակում, վերականգնում և փակում՝ նախկին գործողությունների պատմության պահպանմամբ:
ADM-02	Դերերի ստեղծում և փոփոխում, ինչպես նաև մեկ օգտատիրոջը մի քանի դեր տրամադրելու հնարավորություն:

ID	Պարտադիր գործառնություն
ADM-03	Սկզբնական բազային դերեր՝ գրանցարանի աշխատակից, զանգերի կենտրոնի աշխատակից, գանձապահ, ամբուլատոր բժիշկ, ստացիոնար բժիշկ, հերթապահ բժիշկ, խորհրդատու բժիշկ, բուժքույր, ավագ բուժքույր, լաբորատորիայի աշխատակից, լաբորատոր արդյունքը հաստատող մասնագետ, ճառագայթային ախտորոշման աշխատակից, ախտորոշիչ արդյունքը հաստատող բժիշկ, բաժանմունքի ղեկավար, ֆինանսական ծառայության աշխատակից, բժշկական փաստաթղթերի վերահսկող, բժշկական համալիրի ղեկավար և համակարգի ադմինիստրատոր:
ADM-04	Յուրաքանչյուր դերի համար դիտման, ստեղծման, փոփոխման, հաստատման, չեղարկման, արտահանման, ֆինանսական գործողությունների և համակարգային կարգավորումների առանձին իրավունքներ:
ADM-05	Հասանելիության սահմանափակում ըստ մասնաշենքի, ստորաբաժանման, ծառայության, մասնագիտության և պացիենտի բուժմանը մասնակցության:
ADM-06	Բժշկական և ֆինանսական իրավասությունների տարանջատում:
ADM-07	Մուտքանուն/գաղտնաբառ, առաջին մուտքի փոփոխություն, բարդության կանոններ, անհաջող փորձերից հետո արգելափակում և անգործության սեսիայի ավարտ:
ADM-08	Բարձր արտոնություններով օգտատերերի երկփուլ նույնականացման հնարավորություն, եթե այն ապահովվում է ընտրված նույնականացման տեխնիկական լուծմամբ՝ առանց առանձին վճարովի արտաքին ինտեգրման:
ADM-09	Փաստաթղթի ներքին էլեկտրոնային հաստատում՝ հեղինակի, խմբագրողի, հաստատողի, ամսաթվի, ժամի և տարբերակի պահպանմամբ:
ADM-10	Audit Trail՝ գործողություն, օգտատեր, ամսաթիվ/ժամ, օբյեկտ և հասանելիության դեպքում նախկին/նոր արժեք, IP կամ սարքի տեխնիկական տվյալներ:
ADM-11	Հաստատված գրառումների վերահսկվող ուղղում՝ առանց սկզբնական տարբերակի կորստի:
ADM-12	Արտակարգ հասանելիություն (break-glass)՝ պատճառի պարտադիր նշմամբ և առանձին աուդիտով:
ADM-13	Առանց ծրագրային կոդի փոփոխության, երբ դա ողջամտորեն կիրառելի է՝ ստորաբաժանումների, մասնագիտությունների, աշխատակիցների կապերի, ծառայությունների, ձևանմուշների, կարգավիճակների, ծանուցումների և փաստաթղթերի վերնամասերի կառավարում:

ADM-03-ում թվարկված դերերը սկզբնական ստանդարտ կազմն են և չեն փոխարինում Պատվիրատուի փաստացի կազմակերպական կառուցվածքին: Մշակման մեկնարկից հետո Պատվիրատուն տրամադրում է իր ստորաբաժանումների, աշխատակիցների, պաշտոնների և դերերի համապատասխանեցման տվյալները, իսկ Կատարողը մինչև UAT-ը դրանց հիման վրա կատարում է սկզբնական կարգավորումը: Գործող իրավունքների համակցությամբ նոր դերերի ստեղծումը և աշխատակիցների վերանշանակումը կատարվում են համակարգի վարչարարական գործիքներով՝ առանց ծրագրային կոդի փոփոխության: Նոր էկրան, նոր workflow կամ նախկինում չնախատեսված տվյալային սահմանափակում պահանջող դերը համարվում է նոր գործառնության պահանջ:

Սահմանափակումներ. SSO-ն, կենսաչափական նույնականացումը, աշխատակցի քարտերով մուտքը, սարքերի կենտրոնացված կառավարումը, DLP/SIEM/PAM համակարգերը և արտաքին identity provider-ի ինտեգրումը Փուլ I-ում ներառված չեն:

6. Փուլ I-ի հաշվետվությունների փակ գրանցամատյանը

6.1. Ստորև թվարկված յուրաքանչյուր տեղեկատվական արդյունք ներառված է Փուլ I-ում: Կրկնվող արդյունքները կարող են իրականացվել մեկ ընդհանուր հաշվետվությամբ, վահանակի տարրով կամ զտված ներկայացմամբ: Ցանկը չի նշանակում առանձին էկրանի ստեղծում յուրաքանչյուր տողի համար:

6.2. Ախտորոշիչ և բուժական ծառայություններ

1. նշանակված ծառայությունների քանակ,
2. կատարված ծառայությունների քանակ,
3. չկատարված և չեղարկված պատվերներ,
4. ծառայությունների բաշխում ըստ տեսակի,
5. ծառայությունների բաշխում ըստ ստորաբաժանման,
6. ծառայությունների բաշխում ըստ նշանակող բժշկի,
7. սպասման միջին ժամանակ,
8. արդյունքների պատրաստման միջին ժամանակ,
9. կրիտիկական լաբորատոր արդյունքների քանակ,
10. չհաստատված արդյունքների ցանկ:

6.3. Ֆինանսական արդյունքներ

1. օրվա ընդհանուր հասույթ,
2. հասույթ ըստ վճարման եղանակի,
3. հասույթ ըստ ստորաբաժանման,
4. հասույթ ըստ ծառայության,
5. հասույթ ըստ բժշկի՝ կատարված ծառայությունների հիման վրա և առանց աշխատավարձի հաշվարկի,
6. հասույթ ըստ վճարողի,
7. կիրառված զեղչեր,
8. կատարված վերադարձներ,
9. կանխավճարների մնացորդներ,
10. չվճարված և մասնակի վճարված հաշիվներ,
11. գանձապահների հերթափոխային հաշվետվություններ,
12. ծառայությունների քանակ և արժեք,

13. ընտրված ժամանակահատվածի ֆինանսական ամփոփում:

6.4. Ամբուլատոր և ստացիոնար գործառնական արդյունքներ

1. ամբուլատոր այցեր ըստ ժամանակահատվածի,
2. ամբուլատոր այցեր ըստ բժշկի,
3. ամբուլատոր այցեր ըստ մասնագիտության,
4. առաջին և կրկնակի այցերի հարաբերակցություն,
5. հոսպիտալացումներ ըստ ժամանակահատվածի,
6. դուրսգրումներ,
7. մահճակալային ֆոնդի օգտագործում,
8. ստորաբաժանումների ծանրաբեռնվածություն,
9. հոսպիտալացման միջին տևողություն:

6.5. Ադմինիստրատիվ և անվտանգության արդյունքներ

1. ակտիվ օգտատերերի ցանկ,
2. արգելափակված և փակված հաշիվների ցանկ,
3. օգտատերերի բաշխում ըստ դերի,
4. օգտատերերի բաշխում ըստ ստորաբաժանման,
5. վերջին մուտքերի պատմություն,
6. մուտքի անհաջող փորձեր,
7. արտակարգ հասանելիության դեպքեր,
8. տվյալների արտահանման դեպքեր,
9. հաստատված գրառումների ուղղումների պատմություն,
10. բարձր արտոնություններով օգտատերերի ցանկ:

6.6. Հաշվետվություններն օգտագործում են Համակարգում առկա տվյալները և տրամադրում են կիրառելի զտիչներ՝ ժամանակահատված, ստորաբաժանում, բժիշկ, ծառայության տեսակ և այլ ուղղակիորեն անհրաժեշտ չափանիշներ: Ցուցանիշների ներկայացման ձևը, սյունակները և հաշվարկման տեխնիկական կանոնները համաձայնեցվում են մշակման ընթացքում՝ չփոխելով սույն բաժնի տեղեկատվական արդյունքները: Նոր ցուցանիշը կամ նոր տվյալների աղբյուրը համարվում է փոփոխության հայտ:

7. Ձևանմուշներ, տեղեկատուներ և սկզբնական տվյալներ

7.1. Բժշկական ձևանմուշների կոնստրուկտոր

Փուլ I-ում ներառվում է ծրագրային կոնստրուկտոր, որը լիազորված օգտատիրոջը հնարավորություն է տալիս՝

- ստեղծել և փոփոխել բժշկական ձևանմուշ,

- ավելացնել տեքստային, թվային, ամսաթվային և ընտրության դաշտեր,
- սահմանել դաշտի պարտադիր լինելը,
- սահմանել պատասխանի ընտրանքներ,
- ձևանմուշը կապել մասնագիտության կամ ծառայության հետ,
- ակտիվացնել նոր տարբերակը և պահպանել տարբերակների պատմությունը:

Կոնստրուկտորը պետք է թույլ տա ստեղծել տարբեր մասնագիտությունների և ծառայությունների ձևանմուշներ, ներառյալ նախնական պահանջներում հիշատակված առնվազն 12 բժշկական ուղղությունները: Այս պահանջը վերաբերում է ծրագրային հնարավորությանը և չի նշանակում Կատարողի կողմից 12 պատրաստ բժշկական ձևանմուշի ստեղծում:

7.2. Ձևանմուշների բովանդակության և աջակցության սահմանը

Փուլ I-ի շրջանակում Կատարողը ողջամիտ ծավալով աջակցում է առաջին գործարկման փաստաթղթերի փաթեթի ձևավորմանը՝

- ուսումնասիրում է Պատվիրատուի տրամադրած նմուշներն ու չափորոշիչները,
- որոնում և առաջարկում է հրապարակայնորեն հասանելի պաշտոնական կամ գործնականում կիրառվող օրինակներ,
- օգնում է կառուցվածքավորել համաձայնեցված ձևերի դաշտերը,
- կոնստրուկտորի հնարավորությունների սահմաններում աջակցում է համաձայնեցված մեկնարկային ձևերի տեխնիկական կարգավորմանը:

Պատվիրատուն տրամադրում է առաջին գործարկման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի փակ ցանկը, իր մոտ առկա նմուշները և պարտադիր չափորոշիչները: Եթե որոշ փաստաթղթի բժշկական կամ իրավական բովանդակությունը հնարավոր չէ միանշանակ որոշել հասանելի պաշտոնական աղբյուրներով, այն տրամադրում կամ հաստատում է Պատվիրատուի լիազորված բժշկական կամ իրավաբանական մասնագետը: Վերջնական բժշկական և իրավական բովանդակության հաստատման պատասխանատվությունը կրում է Պատվիրատուն:

Փուլ I-ի ֆիքսված մշակման արժեքում **չեն ներառվում՝**

- բժշկական բովանդակության մշակում կամ բժշկական մեթոդաբանության հեղինակային կազմում,
- իրավաբանական եզրակացության կամ պարտադիր պետական ձևի իրավական վավերության հաստատում,
- չսահմանափակված կամ զանգվածային թղթային արխիվի թվայնացում,
- կոնստրուկտորի հնարավորություններից դուրս առանձին ծրագրային մշակում պահանջող ձևեր,
- անսահմանափակ խմբագրումների, բովանդակային վերամշակման կամ հետգործարկման զանգվածային մուտքագրման աշխատանքներ:

Կոնստրուկտորի սահմաններում փոքր ճշգրտումները և համաձայնեցված մեկնարկային փաթեթի ողջամիտ տեխնիկական աջակցությունը չեն համարվում առանձին նոր գործառույթ: Կոնստրուկտորից դուրս նոր վարքագիծ պահանջող ձևը գնահատվում է որպես ծրագրային փոփոխության հայտ:

7.3. Տեղեկատվություն և սկզբնական բովանդակություն

Կատարողը տրամադրում է նախատեսված տեղեկատվության կառավարման և համաձայնեցված ֆայլից ներմուծման գործառնությունները: Պատվիրատուն պատրաստում, մաքրում և հաստատում է առնվազն հետևյալ բովանդակությունը՝

- կազմակերպական կառուցվածք, ստորաբաժանումներ, հիվանդասենյակներ և մահճակալներ,
- աշխատակիցներ, մասնագիտություններ, դերերի բաշխման հիմքեր և ժամանակացույցեր,
- ծառայությունների կատալոգ, կոդեր, գներ և վճարողների տվյալներ,
- կիրառվող ICD տարբերակ/տեղայնացում,
- դեղերի, լաբորատոր հետազոտությունների, միավորների, հղումային միջակայքների և կրիտիկական շեմերի կիրառելի տեղեկատվություններ,
- փաստաթղթերի վերնամասեր, հաստատված տեքստեր և իրավական ձևակերպումներ:

Պատվիրատուն պատասխանատու է փոխանցված տվյալների ճշտության, ամբողջականության, արդիականության և օգտագործման իրավունքի համար: Կատարողը պատասխանատու չէ բժշկական կամ իրավական բովանդակության սխալի համար, եթե այն վերարտադրում է Պատվիրատուի հաստատած աղբյուրը:

7.4. Սկզբնական ներբեռնում և պատմական տվյալների տեղափոխում

Փուլ I-ում ներառվում են՝

1. համաձայնեցված սկզբնական տեղեկատվությունների ներմուծման գործառնություն,
2. Պատվիրատուի կողմից պատրաստված, մաքրված և հաստատված ֆայլերի մեկ սկզբնական ներբեռնումը:

Հին համակարգերից տվյալների դուրսբերումը, աղբյուրների ուսումնասիրությունը, mapping-ը, մաքրումը, կրկնօրինակների վերացումը, ձևաչափերի փոխակերպումը, պատմական բժշկական/ֆինանսական տվյալների ու ֆայլերի տեղափոխումը և թղթային արխիվի թվայնացումը ներառված չեն: Անհրաժեշտության դեպքում դրանք գնահատվում են առանձին՝ աղբյուրների նախնական ուսումնասիրությունից հետո:

Կողմերը հաստատում են, որ բժշկական համալիրը նոր է, պարտադիր պատմական կամ legacy տվյալների աղբյուրներ չկան, և Փուլ I-ի համար պատմական տվյալների տեղափոխում չի պահանջվում:

8. API, արտաքին ինտեգրումներ և էլեկտրոնային հաստատում

8.1. API-ի հիմք

Փուլ I-ում ներառվում են՝

- արտաքին ինտեգրումների հետագա ավելացման համար API-շերտի ճարտարապետական հիմքը,
- Փուլ I-ի շրջանակում համաձայնեցված բազային ինտեգրացիոն միջերեսի փաստաթղթավորումը,

- նույնականացման, տարբերակավորման և սխալների մշակման բազային կանոնների նկարագրությունը:

Ներքին բոլոր ծրագրային API-ների հրապարակումը, յուրաքանչյուր հնարավոր բիզնես գործողության արտաքին endpoint-ը և երրորդ կողմի կոնկրետ կապակցիչը ներառված չեն, եթե ուղղակիորեն նշված չեն սույն SL-ում:

8.2. Փուլ I-ում չներառված ինտեգրումները

Առանց առանձին գրավոր ծավալի և արժեքի Փուլ I-ը չի ներառում ինտեգրում՝

- ARMED-ի, ՀՀ էլեկտրոնային առողջապահության այլ պետական կամ լիազորված հարթակների հետ,
- ապահովագրական և պայմանագրային կազմակերպությունների համակարգերի հետ,
- հաշվապահական, հարկային, ֆինանսական, բանկային, POS/acquiring կամ վճարային համակարգերի հետ,
- լաբորատոր անալիզատորների, LIS-ի կամ արտաքին լաբորատորիաների հետ,
- PACS/RIS/DICOM համակարգերի և ռենտգեն, ԿՏ, ՄՌՏ, ՈւՁՀ կամ այլ ախտորոշիչ սարքերի հետ,
- ICU սարքերի, մոնիտորների, արհեստական շնչառության սարքերի, պոմպերի կամ այլ բժշկական սարքավորումների հետ,
- SMS, e-mail, հեռախոսային կամ այլ արտաքին ծանուցման ծառայությունների հետ,
- որակավորված էլեկտրոնային ստորագրության և հավաստագրային ծառայությունների հետ:

Փուլ I-ում ARMED-ի հետ ավտոմատ տեխնիկական ինտեգրում չի իրականացվում:

Պատվիրատուն մինչև լիցենզավորված բժշկական գործունեության մեկնարկը ինքնուրույն ապահովում է էլեկտրոնային առողջապահության պետական համակարգի օպերատորի հետ անհրաժեշտ պայմանագրային հարաբերությունները, միացումը, օգտատերերի հասանելիությունները և օրենսդրությամբ պահանջվող տվյալների մուտքագրումը: Մինչև հետագա առանձին ինտեգրման իրականացումը Պատվիրատուի պատասխանատու աշխատակիցներն այդ գործողությունները կատարում են անմիջապես պետական համակարգի միջոցով՝ սույն HIS-ից անկախ:

8.3. Ներքին հաստատում և իրավաբանական փաստաթղթեր

Փուլ I-ում Համակարգն ապահովում է ներքին էլեկտրոնային հաստատում և Audit Trail: Այն ինքնաբերաբար չի համարվում որակավորված էլեկտրոնային ստորագրություն: Այն փաստաթղթերը, որոնց համար կիրառելի իրավական կամ ներքին կարգով ներքին հաստատումը բավարար չէ, մինչև հետագա որակավորված էլեկտրոնային ստորագրության ինտեգրումը տալվում և ստորագրվում են Պատվիրատուի սահմանած կարգով:

9. Տվյալների սեփականություն և սկզբնական կոդ

9.1. Պատվիրատուի տվյալները

Համակարգում Պատվիրատուի գործունեության արդյունքում ստեղծված բժշկական, ֆինանսական, տեղեկատու, ադմինիստրատիվ տվյալները, փաստաթղթերը, կարգավորումները և թվային նյութերը պատկանում են Պատվիրատուին:

9.2. Սկզբնական կոդ և գույքային իրավունքներ

Փուլ I-ի ամբողջական վճարումից հետո Պատվիրատուին փոխանցվում են՝

- Փուլ I-ի շրջանակում մշակված ծրագրային գործառնությունների սկզբնական կոդը,
- նախագծի Git շտեմարանը՝ փոխանցման պահին առկա պատմությամբ,
- հավաքման և տեղակայման համար անհրաժեշտ հրահանգները,
- մշակված կոդն օգտագործելու, վերարտադրելու, փոփոխելու և Պատվիրատուի կողմից ներգրավված այլ մշակողին փոխանցելու բացառիկ գույքային իրավունքները՝ երրորդ կողմերի և բաց կոդով բաղադրիչների լիցենզիաներով նախատեսված սահմանափակումներով:

Յուրաքանչյուր հետագա՝ առանձին վճարվող փուլի արդյունքների կոդն ու համապատասխան իրավունքները փոխանցվում են տվյալ փուլի ամբողջական վճարումից հետո: Երրորդ կողմերի և բաց կոդով բաղադրիչները կարգավորվում են իրենց լիցենզիաներով: Կատարողը փոխանցման փաթեթում ներկայացնում է նման բաղադրիչների և կիրառվող լիցենզիաների ցանկը:

10. Ծարտարապետական և ոչ գործառնության պահանջներ

10.1. Ծարտարապետություն

Համակարգը պետք է ունենա մոդուլային, բազմաշերտ ճարտարապետություն, կենտրոնացված տվյալներ, պացիենտի միասնական նույնականացում, միասնական դերային կառավարում և հետագա մոդուլների ու ինտեգրումների ավելացման հնարավորություն՝ առանց հիմնական համակարգի ամբողջական վերաշարադրման:

10.2. Արտադրողականություն և մասշտաբավորում

Հիմնական գործողությունները, որոնումը և ընթացիկ հաշվետվությունները չպետք է նկատելիորեն խոչընդոտեն ամենօրյա աշխատանքին համաձայնեցված արտադրական ենթակառուցվածքի և բեռնվածության սահմաններում: Ծանր հաշվարկները հնարավորության դեպքում կատարվում են ֆոնային եղանակով:

Առաջին գործարկման նախնական չափը 150–200 աշխատակից է: Այս թիվը չի հավասարեցվում 150–200 միաժամանակյա սեսիայի: Սերվերային վերջնական հաշվարկը և չափելի բեռնվածության ընդունման չափանիշները որոշվում են Պատվիրատուի կողմից տրամադրված իրական բեռնվածության նկարագրի հիման վրա: Չսահմանված կամ անսահմանափակ բեռնվածության պարտավորություն չի առաջանում:

10.3. Շուրջօրյա աշխատանքի պատրաստություն

Ծրագրային ապահովումը նախագծվում է 24/7 շահագործման համար՝ անվտանգ պլանային թարմացումների, սխալների գրանցման և տեխնիկական վերահսկման հնարավորությամբ: Այս պահանջը չի նշանակում բարձր հասանելիության կլաստերի, պահուստային հարթակի, multi-region ճարտարապետության, ավտոմատ failover-ի, երաշխավորված uptime տոկոսի կամ 24/7 մարդկային աջակցության ներառում Փուլ I-ի մշակման արժեքում:

10.4. Բազային տեղեկատվական անվտանգություն

Փուլ I-ում ներառվում են՝

- պաշտպանված կապի կիրառում արտադրական միջավայրում,
- գաղտնաբառերի անվտանգ պահպանում,
- դերային հասանելիություն և նվազագույն անհրաժեշտ իրավունքի սկզբունք,
- սեսիաների կառավարում և անհաջող մուտքերի վերահսկում,
- բժշկական, ֆինանսական և ադմինիստրատիվ գործողությունների Audit Trail,
- հաստատված տվյալների վերահսկվող ուղղում,
- տվյալների արտահանման իրավունքների սահմանափակում,
- կիրառական սխալների և անվտանգության նշանակություն ունեցող իրադարձությունների գրանցում:

10.5. Պահուստավորում և վերականգնում

Փուլ I-ի տեխնիկական գործարկման մեջ ներառվում են բազային ավտոմատ պահուստավորման կարգավորումը և մեկ փաստաթղթավորված վերականգնման փորձարկում: Պատճենների հաճախականությունը, պահպանման ժամկետը, ամպային պահոցի արժեքը, RPO/RTO-ն, պահուստային հարթակը և աղետից վերականգնման ընդլայնված ճարտարապետությունը սահմանվում են արտադրական ենթակառուցվածքի և տեխնիկական սպասարկման առանձին պայմաններով:

11. Տեղակայում, միջավայրեր և տեխնիկական սպասարկում

11.1. Մշակման և նախնական ցուցադրությունների ընթացքում Կատարողը տրամադրում է իր ժամանակավոր թեստային միջավայրը՝ առանց առանձին server/maintenance վճարի մինչև Փուլ I-ի փորձնական թողարկման փոխանցումը:

11.2. Փուլ I-ի փորձնական թողարկումը տեղակայվում է ամպային արտադրական միջավայրում: Ամպային մատակարարին, տարածաշրջանին և տեխնիկական կազմաձևին առաջարկում է Կատարողը և հաստատում է Պատվիրատուն: Փուլ I-ի մատակարարման մեջ ներառվում է պատրաստ հավելվածի մեկ տեխնիկական production տեղակայում համաձայնեցված միջավայրում:

11.3. Փուլ I-ի մշակման ֆիքսված արժեքում ներառված չեն արտադրական ամպային ռեսուրսները, պահոցը, ցանցը, domain/certificate ծախսերը, առևտրային լիցենզիաները, երրորդ կողմերի ծառայությունները, աշխատատեղերը, սարքավորումները և պարբերական այլ վճարները, եթե դրանք ուղղակիորեն ներառված չեն Պայմանագրի առևտրային հավելվածում:

11.4. Արտադրական ամպային ռեսուրսների և տեխնիկական սպասարկման վճարումը սկսվում է արտադրական փորձնական տեղակայումից՝ առանձին համաձայնագրի կամ առևտրային հավելվածի պայմաններով:

11.5. Տեխնիկական սպասարկումը և SLA-ն առանձին վճարովի ծառայություններ են: Դրանք չեն փոխարինում Կատարողի՝ սույն SLA-ի հաստատված գործառույթների ծրագրային թերությունները անվճար շտկելու պարտավորությանը:

12. Մատակարարվող արդյունքները

Փուլ I-ի շրջանակում Կատարողը մատակարարում է՝

1. սույն SLA-ի բաժին 5-ում սահմանված յոթ գործառնության մոդուլների աշխատունակ ծրագրային իրականացումը,
2. բաժին 6-ի հաշվետվական արդյունքները,
3. բժշկական ձևանմուշների կոնստրուկտորը,
4. սկզբնական տեղեկատվությունների համաձայնեցված ներմուծման գործառնությամբ և մեկ ներբեռնում,
5. բազային API/ինտեգրացիոն միջերեսի տեխնիկական նկարագրությունը,
6. Կատարողի ժամանակավոր թեստային միջավայրը մինչև փորձնական թողարկման փոխանցումը,
7. համաձայնեցված ամպային արտադրական միջավայրում մեկ տեխնիկական տեղակայում,
8. բազային ավտոմատ պահուստավորման կարգավորում և մեկ վերականգնման փորձարկման արձանագրություն,
9. ուսուցողական տեսադասընթաց և օգտագործողի ուղեցույց,
10. վերջնական ընդունման պահին արդիական էլեկտրոնային as-built տեխնիկական փաստաթղթերի փաթեթ,
11. Փուլ I-ի ամբողջական վճարումից հետո՝ բաժին 9.2-ում նշված սկզբնական կողմ, Git շտեմարանը և փոխանցման նյութերը:

12.1. Տեխնիկական փաստաթղթերի կազմը

Վերջնական as-built փաթեթը ներառում է՝

- Համակարգի ճարտարապետության նկարագրություն,
- տվյալների բազայի կառուցվածքի նկարագրություն,
- արտաքին ինտեգրացիոն միջերեսի/API-ի նկարագրություն,
- տեղակայման և հավաքման հրահանգ,
- շահագործման ուղեցույց,
- տեխնիկական սպասարկման ուղեցույց,
- պահուստավորման և վերականգնման ընթացակարգ,
- թարմացման ընթացակարգ,
- օգտատիրոջ ուղեցույց:

Պատվիրատուին ուղղված հիմնական օգտագործողի նյութերը կազմվում են հայերեն: API-ի, տվյալների բազայի, ծրագրային կողմի և հավաքման տեխնիկական նյութերում թույլատրվում են ընդունված անգլերեն տերմիններ և տեխնիկական նշագրումներ: Վերջնական ակտից հետո փաստաթղթերի հետագա թարմացումը կատարվում է տեխնիկական սպասարկման կամ նոր մշակման շրջանակում:

12.2. Ուսուցման սահմանը

Փուլ I-ի արժեքում ներառվում են տեսադասընթացը և օգտագործողի ուղեցույցը:
Դասընթացավարի մասնակցությամբ առկա կամ առցանց դասընթացները, անհատական ուսուցումը, բաժանմունքային խմբերը և կրկնակի վերապատրաստումը ներառված չեն և, անհրաժեշտության դեպքում, գնահատվում են առանձին:

13. Իրականացման ժամկետ և արտադրական փորձնական շահագործում

13.1. Արտադրական փորձնական թողարկման փոխանցման ժամկետը Փուլ I-ի մեկնարկից **չորս ամիս** է: Մեկնարկի օրը նշվում է սույն ՏԱ-ի վերնամասում կամ Պայմանագրով նախատեսված առանձին մեկնարկի ակտում:

13.2. Չորս ամսվա արդյունքը վերջնական ընդունման ակտ չէ: Այն արտադրական փորձնական թողարկում է, որով Պատվիրատուն սկսում է Համակարգի ստուգումը իրական աշխատանքային սցենարներով:

13.3. Փորձնական թողարկման փոխանցման պահին կրիտիկական/արգելափակող թերություններ չեն թույլատրվում:

Փորձնական թողարկման պահին կարող են առկա լինել հայտնի ոչ կրիտիկական թերություններ, մասնակի տեխնիկական անհամապատասխանություններ կամ այլ ոչ էական խնդիրներ, եթե դրանք չեն արգելափակում Համակարգի համապատասխան հիմնական աշխատանքային գործընթացների իրականացումը և չեն ստեղծում պացիենտի անվտանգության, տվյալների ամբողջականության կամ գաղտնիության էական վտանգ:

Նման թերությունները ներառվում են Կատարողի կողմից վարվող և Կողմերի կողմից համաձայնեցվող միասնական թերությունների գրանցամատյանում՝ նկարագրությամբ, դասակարգմամբ, առաջնահերթությամբ, շտկման համաձայնեցված ժամկետով և կարգավիճակով: Դրանք առանց լրացուցիչ մշակման վճարի շտկվում են արտադրական փորձնական շահագործման ընթացքում, իսկ եթե համաձայնեցված կերպով մնում են Փուլ I-ի վերջնական ընդունման պահին՝ գրանցամատյանում սահմանված ժամկետներում:

13.4. Պատվիրատուի կողմից տվյալների, հաստատումների, ձևանմուշների բովանդակության, տեղեկատվությունների, հասանելիությունների, արտադրական ենթակառուցվածքի կամ որոշումների ուղացումը համապատասխան չափով երկարաձգում է այն աշխատանքների ժամկետը, որոնք փաստաթղթավորված կերպով կախված են տվյալ մուտքային նյութից կամ որոշումից:

14. Փորձարկում և ընդունում

14.1. Փորձարկման մակարդակները

Փուլ I-ի ընդունման համար կիրառվում են՝

- Կատարողի ներքին մոդուլային և ինտեգրացիոն փորձարկումները,
- հիմնական դերերի և գործառույթների իրական սցենարներով UAT/փորձնական ստուգումը,
- պահուստավորումից մեկ վերահսկվող վերականգնման փորձարկումը,

- արտադրական փորձնական շահագործումը,
- հայտնաբերված Փուլ I-ի թերությունների ուղղում և կրկնակի ստուգում:

UAT սցենարները ստուգում են միայն սույն SU-ի հաստատված պահանջները և չեն կարող առանց ստորագրված փոփոխության հայտի ավելացնել նոր գործառույթ կամ ընդլայնել առկա պահանջը:

14.2. Վերջնական ընդունման պայմանները

Փուլ I-ը վերջնականապես ընդունված է համարվում, երբ միաժամանակ՝

1. սույն SU-ի պարտադիր մոդուլները տեղակայված և փոխկապակցված են,
2. պարտադիր սցենարները կատարվել են,
3. շտկվել են բոլոր կրիտիկական/արգելափակող թերությունները և այն այլ էական թերությունները, որոնք անհնար են դարձնում կամ էականորեն խոչընդոտում են Տեխնիկական առաջադրանքով նախատեսված հիմնական աշխատանքային գործընթացների պատշաճ իրականացումը,
4. մնացած ոչ էական և ոչ կրիտիկական թերությունները, եթե այդպիսիք առկա են, ներառված են Կատարողի կողմից վարվող և Կողմերի կողմից համաձայնեցված թերությունների գրանցամատյանում՝ սահմանված առաջնահերթությամբ, շտկման կարգով և ժամկետներով: Նման թերությունների առկայությունն ինքնին չի խոչընդոտում Փուլ I-ի վերջնական ընդունմանը,
5. դերերն ու իրավասությունները կարգավորված են,
6. պահուստավորման և վերականգնման փորձարկումն իրականացված է,
7. տեսադասընթացը, օգտագործողի ուղեցույցը և տեխնիկական փաստաթղթերը փոխանցված են,
8. Համակարգը աշխատել է համաձայնեցված արտադրական փորձնական ժամանակահատվածում,
9. կողմերը ստորագրել են վերջնական ընդունման ակտը:

14.3. Թերությունների անվճար շտկում և երաշխիք

Սույն SU-ի համաձայնեցված գործառույթի ծրագրային թերությունները Կատարողը շտկում է առանց լրացուցիչ մշակման վճարի՝ փորձնական շահագործման ընթացքում և Պայմանագրով սահմանված երաշխիքային ժամկետում: Այս պարտավորությունը չի վերաբերում՝

- նոր կամ փոփոխված պահանջներին,
- Պատվիրատուի կամ երրորդ կողմի կողմից առանց Կատարողի համաձայնության փոփոխված կոդին,
- երրորդ կողմի ենթակառուցվածքի կամ ծառայության խափանմանը,
- Պատվիրատուի տրամադրած սխալ բժշկական/տեղեկատու տվյալներին,
- Համակարգի համաձայնեցված տեխնիկական սահմաններից դուրս օգտագործմանը:

Բաժին 14.2-ի 4-րդ ենթակետի համաձայն համաձայնեցված գրանցամատյանում ներառված թերությունները շտկվում են այդ գրանցամատյանով սահմանված կարգով և ժամկետներում՝

առանց լրացուցիչ մշակման վճարի: Վերջնական ընդունման ակտի ստորագրումը Կատարողին չի ազատում այդ թերությունների շտկման պարտավորությունից:

Վերջնական ակտից հետո անվճար երաշխիքի կոնկրետ ժամկետը պարտադիր լրացվում է բաժին 19-ի աղյուսակում կամ Պայմանագրում: Վճարովի maintenance/SLA-ն և ծրագրային երաշխիքը տարբեր պարտավորություններ են:

14.4. Փոփոխության հայտերի կառավարում

Փոփոխության հայտը ձևակերպվում է գրավոր և առնվազն պարունակում է պահանջի նկարագրությունը, Փուլ I-ի վրա ազդեցությունը, արժեքը և ժամկետը: Կատարողը պարտավոր չէ սկսել փոփոխության իրականացումը մինչև կողմերի գրավոր հաստատումը: Փոփոխության հայտի քննարկումը ինքնին չի նշանակում այն ներառել Փուլ I-ի ֆիքսված արժեքում:

15. Կողմերի պարտականությունները

15.1. Կատարողի պարտականությունները

Կատարողը պարտավորվում է՝

- մշակել և մատակարարել սույն SLA-ի փակ ծավալը,
- վարել պահանջների, ցուցադրությունների և թերությունների վերահսկվող գրանցամատյան,
- նախապես տեղեկացնել հայտնաբերված էական ռիսկերի ու կախվածությունների մասին,
- ապահովել մշակման թեստային միջավայրը մինչև փորձնական փոխանցումը,
- կատարել համաձայնեցված production տեղակայումը,
- շտկել հաստատված ծավալի ծրագրային թերությունները,
- փոխանցել սույն SLA-ով նախատեսված փաստաթղթերը, տվյալների արտահանման հնարավորությունը և վճարումից հետո սկզբնական կողմ,
- պաշտպանել իրեն հասանելի դարձած բժշկական և անձնական տվյալների գաղտնիությունը:

15.2. Պատվիրատուի պարտականությունները

Պատվիրատուն պարտավորվում է ժամանակին՝

- նշանակել իրավասու պատասխանատու անձանց՝ պահանջների, բժշկական բովանդակության, ֆինանսական կանոնների և ընդունման համար,
- մշակման մեկնարկից հետո համաձայնեցված ձևաչափով տրամադրել **կազմակերպական և սկզբնական տվյալների փաթեթը**՝ առաջին գործարկման ստորաբաժանումները, ծառայությունները, մասնագիտությունները, հիվանդասենյակները, մահճակալները, աշխատակիցները, պաշտոնները, դերերի համապատասխանեցումը, ժամանակացույցերը, ծառայությունների կատալոգը, կողերը, գները, վճարողների տվյալները, կիրառվող ICD-ն, դեղերի և լաբորատոր հետազոտությունների տեղեկատվությունը, չափման միավորները, հղումային միջակայքներն ու կրիտիկական շեմերը,
- մշակման մեկնարկից հետո տրամադրել **փաստաթղթերի և ձևանմուշների փաթեթը**՝ առաջին գործարկման համար անհրաժեշտ բժշկական և վարչական փաստաթղթերի փակ ցանկը, առկա նմուշները, պետական/ներքին չափորոշիչները, հաստատված տեքստերը և բովանդակությունը հաստատող լիազորված բժշկական կամ իրավաբանական մասնագետներին,

- տրամադրել օգտագործման իրավունքը բոլոր փոխանցվող նյութերի նկատմամբ,
- ինքնուրույն ապահովել ARMED-ի կամ կիրառելի պետական էլեկտրոնային առողջապահական համակարգի հետ պայմանագիրը, միացումը, հասանելիությունները և պարտադիր տվյալների մուտքագրումը մինչև հետագա ինտեգրումը,
- ապահովել արտադրական ամպային ռեսուրսների և երրորդ կողմի վճարովի ծառայությունների գնումը,
- ապահովել UAT-ին լիազորված օգտատերերի մասնակցությունը և համաձայնեցված ժամկետում համախմբված արձագանքը,
- չօգտագործել նոր ցանկությունը որպես արդեն համաձայնեցված թերության նկարագրություն:

16. Փուլ I-ում ուղղակիորեն չներառված ծավալը

Ստորև թվարկված աշխատանքները և դրանց հետ համարժեք ընդլայնումները ներառված չեն Փուլ I-ում, եթե կողմերը դրանք առանձին չեն ավելացրել ստորագրված փոփոխությամբ՝

1. դեղատան և պահեստների ամբողջական կառավարում, պահեստային մնացորդ, խմբաքանակ, ժամկետ, գնում և ավտոմատ դուրսգրում,
2. վիրահատարանների, սրահների, սարքավորումների, թիմերի և օրացույցի ամբողջական կառավարում,
3. ընդլայնված բուժքույրական մոդուլ, mobile nursing workplace, barcode medication administration, էլեկտրոնային care plan և workload management,
4. HR, անձնակազմի ամբողջական կառավարում, հերթափոխերի ընդլայնված հաշվառում և աշխատավարձ,
5. Որակի կառավարման առանձին մոդուլ, ընդլայնված quality KPI, incident/risk management և accreditation workflow,
6. լիարժեք LIS, PACS/RIS/DICOM և բժշկական սարքավորումների բոլոր ավտոմատ ինտեգրումները,
7. ամբողջական ապահովագրական claims, eligibility, coverage, limits, pre-authorization և ապահովագրողի պորտալ,
8. պայմանագրերի ամբողջական կառավարում և սահմանաչափերի ավտոմատ վերահսկում,
9. POS/acquiring, առցանց կամ բջջային վճարումներ, հարկային/ֆիսկալ և հաշվապահական ավտոմատ ինտեգրումներ,
10. ամբողջական BI, universal report builder, կանխատեսումներ, շահութաբերության և ինքնարժեքի խորքային հաշվարկ,
11. պացիենտի պորտալ, բջջային հավելված, հեռաբժշկություն և ինքնասպասարկման տերմինալներ,
12. SMS/e-mail կամ այլ արտաքին ծանուցման ծառայությունների ինտեգրում,
13. որակավորված արտաքին էլեկտրոնային ստորագրություն,
14. SSO, biometric, employee card, DLP, SIEM, PAM և այլ ընդլայնված անվտանգության ինտեգրումներ,

15. ձայնից տեքստ, AI ամփոփում, կանխատեսող վերլուծություն և այլ AI գործառնություններ,
16. պատմական/legacy տվյալների տեղափոխում և թղթային փաստաթղթերի թվայնացում,
17. Պատվիրատուի փոխարեն բժշկական կամ իրավական բովանդակության հեղինակային ստեղծում, իրավական վավերության հաստատում, անսահմանափակ կամ զանգվածային ձևանմուշների/տվյալների մուտքագրում և թղթային արխիվի թվայնացում,
18. production cloud-ի, լիցենզիաների, երրորդ կողմի ծառայությունների, maintenance-ի և SLA-ի պարբերական արժեք,
19. HA cluster, reserve site, multi-region, automatic failover, երաշխավորված uptime, ընդլայնված DR/RPO/RTO և 24/7 մարդկային սպասարկում,
20. դասընթացավարի մասնակցությամբ ուսուցում և անսահմանափակ հետգործարկման խորհրդատվություն:

17. Հետագա փուլերի ինդիկատիվ ուղղությունները

Սույն բաժինը պարտադիր մշակման կամ գնային առաջարկ չէ: Կողմերը հետագայում կարող են վերախմբավորել ուղղությունները Փուլ II-ի, Փուլ III-ի կամ առանձին նախագծերի միջև:

17.1. Հաջորդ գործառնության ընդլայնումներ

- դեղատոմս և պահեստներ,
- վիրահատարանի ռեսուրսների ամբողջական կառավարում,
- ընդլայնված բուժքույրական աշխատանք և ICU գործառնություններ,
- որակի կառավարում,
- HR և աշխատավարձ,
- պայմանագրերի ու ապահովագրական գործընթացների ընդլայնում:

17.2. Ինտեգրացիոն և թվային ծառայությունների ընդլայնումներ

- պետական, ապահովագրական, հաշվապահական, հարկային և վճարային համակարգեր,
- LIS, լաբորատոր սարքեր և արտաքին լաբորատորիաներ,
- PACS/RIS/DICOM և ճառագայթային/այլ բժշկական սարքեր,
- որակավորված էլեկտրոնային ստորագրություն,
- պացիենտի պորտալ, Mobile, Telemedicine և արտաքին ծանուցումներ,
- BI, research և AI հնարավորություններ:

Ընդհանուր ինտեգրացիոն եզրակացություն. Արտաքին համակարգերի և բժշկական սարքավորումների ինտեգրումների հիմնական մասը նախատեսվում է հետագա փուլերի համար: Փուլ I-ում ստեղծվում է դրանց ճարտարապետական հիմքը և իրականացվում են միայն սույն SU-ում ուղղակիորեն նշված ներքին աշխատանքային հոսքերը:

18. Առանձնահատուկ կարևոր սահմաններ՝ ստորագրելուց առաջ պարտադիր ընթերցման համար

Սույն բաժինը չի փոխարինում SLA-ի ամբողջական ընթերցմանը: Այն կրկնում է միայն այն սահմանները, որոնց սխալ մեկնաբանությունը կարող է էականորեն փոխել Փուլ I-ի ծավալը: Կողմերի ստորագրությունները սույն SLA-ի վերջում նշանակում են նաև ստորև նշված բոլոր պայմանների ընդունում: Ցանկության դեպքում կողմերը կարող են յուրաքանչյուր տողի դիմաց դնել սկզբնատառեր:

№	Կողմերի կողմից հատուկ հաստատվող սահմանը	Պատվիրատուի սկզբնատառեր	Կատարողի սկզբնատառեր
1	Դեղատան ու պահեստների ամբողջական կառավարումը, HR/աշխատավարձը և Որակի կառավարման առանձին մոդուլը Փուլ I-ում ներառված չեն:	—	—
2	Փուլ I-ը փաստաթղթավորում է արդեն կատարված վիրահատությունը, բայց չի կառավարում վիրահատարանի օրացույցն ու ռեսուրսները:	—	—
3	Լաբորատոր և ճառագայթային արդյունքները Փուլ I-ում մուտքագրվում/կցվում են ձեռքով. LIS/PACS/RIS/DICOM և սարքերի ինտեգրումները ներառված չեն:	—	—
4	Ձևանմուշների կոնստրուկտորը և համաձայնեցված մեկնարկային փաթեթի ողջամիտ տեխնիկական աջակցությունը ներառված են, իսկ բժշկական/իրավական բովանդակությունը տրամադրում և վերջնականապես հաստատում է Պատվիրատուն:	—	—
5	Քարտային վճարումը գրանցվում է ձեռքով. POS/acquiring, ֆիսկալ, հաշվապահական և ապահովագրական ավտոմատ ինտեգրումները ներառված չեն:	—	—
6	Պատմական տվյալների տեղափոխումը ներառված չէ. ներառված է միայն պատրաստ սկզբնական տեղեկատվությունների մեկ ներբեռնում:	—	—
7	Production cloud-ը, լիցենզիաները, երրորդ կողմի ծառայությունները, maintenance-ը և SLA-ն վճարվում են առանձին:	—	—
8	Չորս ամիս անց փոխանցվում է production pilot-release, ոչ թե վերջնական ակտ. հայտնի ոչ կրիտիկական թերությունները կարող են շտկվել փորձնական շահագործման ընթացքում և համաձայնեցված գրանցամատյանով ինքնին չեն խոչընդոտում վերջնական ընդունմանը:	—	—
9	Սահմանված Փուլ I-ի ծրագրային թերությունները շտկվում են անվճար, իսկ նոր գործառույթները և աշխատանքի հոսքի փոփոխությունները առանձին փոփոխության հայտ են:	—	—
10	Որակավորված էլեկտրոնային ստորագրությունը ներառված չէ. Փուլ I-ում գործում են ներքին հաստատումը և Audit Trail-ը:	—	—
11	Սկզբնական կոդը, Git շտեմարանը և պայմանագրային իրավունքները փոխանցվում են Փուլ I-ի ամբողջական վճարումից հետո:	—	—
12	Սույն SLA-ում ուղղակիորեն չնշված գործառույթը կամ ինտեգրումը չի համարվում Փուլ I-ի ֆիքսված արժեքի մաս:	—	—

№	Կողմերի կողմից հատուկ հաստատվող սահմանը	Պատվիրատուի սկզբնա տառեր	Կատարողի սկզբնա տառեր
13	ARMED-ի հետ ավտոմատ ինտեգրումը Փուլ I-ում ներառված չէ. մինչև հետագա ինտեգրումը Պատվիրատուն ինքնուրույն ապահովում է պետական համակարգին միացումը և պարտադիր տվյալների մուտքագրումը:	—	—
14	Մշակման մեկնարկից հետո Պատվիրատուն տրամադրում է կազմակերպական/սկզբնական տվյալների և փաստաթղթերի/ձևանմուշների երկու պարտադիր փաթեթները՝ բաժին 15.2-ի համաձայն:	—	—

19. Մինչև ստորագրումը պարտադիր լրացվող պայմաններ

Սույն աղյուսակի արժեքը կարող է լրացվել հենց այստեղ կամ փոխարինվել Պայմանագրի համապատասխան կետի հստակ հղումով: Դատարկ արժեքով ստորագրելը չի նշանակում անսահմանափակ պարտավորություն. այն նշանակում է, որ պայմանը պետք է առանձին գրավոր համաձայնեցվի մինչև համապատասխան աշխատանքի մեկնարկը:

Պայման	Համաձայնեցված արժեք կամ Պայմանագրի կետ
Փուլ I-ի մեկնարկի օրը	_____
Production pilot-release-ի օրը՝ մեկնարկից 4 ամիս հետո	_____
Արտադրական փորձնական շահագործման տևողությունը	_____
UAT/թերությունների վերաբերյալ Պատվիրատուի համախմբված արձագանքի առավելագույն ժամկետը	_____
Վերջնական ընդունման ակտից հետո անվճար երաշխիքային ժամկետը	_____
Production cloud-ի վճարման և maintenance/SLA-ի առանձին փաստաթուղթը	_____
Պատվիրատուի ընդունման պատասխանատու անձը	_____
Կատարողի ծրագրի պատասխանատու անձը	_____

20. Փաստաթղթի ամբողջականություն և փոփոխություններ

20.1. Սույն SLA-ի վերնագրերը և բացատրական տեքստերը ծառայում են պահանջների ճիշտ մեկնաբանմանը և ունեն նույն ուժը, ինչ աղյուսակային պահանջները:

20.2. Եթե որևէ պահանջ տեխնիկապես կարող է իրականացվել մի քանի եղանակով, Կատարողը կարող է ընտրել ողջամիտ իրականացման եղանակը, պայմանով, որ պահպանվում է սույն SU-ով պահանջվող օգտագործողական արդյունքը, անվտանգությունը և տվյալների ամբողջականությունը:

20.3. Կողմերի աշխատանքային հաղորդագրությունը, հանդիպման արձանագրությունը, ցուցադրության մեկնաբանությունը կամ բանավոր համաձայնությունը չեն փոխում Փուլ I-ի ծավալը, մինչև դրանք չեն ձևակերպվել որպես երկու կողմի լիազորված ներկայացուցիչների կողմից ստորագրված Պայմանագրի փոփոխություն կամ փոփոխության հայտ:

20.4. Եթե սույն SU-ի որևէ դրույթ ճանաչվում է անկիրառելի, մնացած դրույթները պահպանում են իրենց ուժը:

21. Կողմերի հաստատումը

Ստորագրելով սույն SU-ն՝ կողմերը հաստատում են, որ՝

- ծանոթացել են փաստաթղթի ամբողջ բովանդակությանը,
- հասկանում և ընդունում են Փուլ I-ի ներառված ու չներառված ծավալները,
- հատկապես ծանոթացել են բաժին 18-ի սահմաններին,
- ընդունում են, որ հետագա փուլերի գործառույթները և բոլոր չթվարկված ընդլայնումները գնահատվում են առանձին,
- հաստատում են, որ սույն SU-ն բավարար հիմք է Փուլ I-ի մշակման մեկնարկի և հետագա ընդունման համար:

Պատվիրատու	Կատարող
Կազմակերպություն՝ _____	Կազմակերպություն՝ _____
Անուն, ազգանուն՝ _____	Անուն, ազգանուն՝ _____
Պաշտոն՝ _____	Պաշտոն՝ _____
Ստորագրություն՝ _____	Ստորագրություն՝ _____
Ամսաթիվ՝ «__» _____ 20__ թ.	Ամսաթիվ՝ «__» _____ 20__ թ.
Կ.Տ.՝ _____	Կ.Տ.՝ _____